

Оценка эффективности применения НАПХТ при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря

Нурғалиев Н.С., Косанов М.С., Онғарбаев Б.Т., Ишкинин Е.И.

Введение

Заболеваемость мышечно-инвазивным РМП на сегодняшний день остается одной из главных проблем современной онкоурологии. Хирургический метод лечения является ведущим в лечении данной нозологии. Тем не менее, отдаленные результаты лечения являются неутешительными. Одними из основных причин получения неудовлетворительных результатов лечения являются позднее осуществление диагностики и несовершенство имеющихся методов терапии. Мышечно-инвазивный РМП в настоящее время рассматривается как диссеминированное заболевание. Более половины больных умирают от возникновения отдаленных метастазов, которые в большинстве случаев присутствовали в виде микрометастазов в начале развития инвазии опухоли. В данной ситуации применение только одного локального хирургического метода является недостаточным. При проведении адъювантной терапии РМП не выявлено убедительных данных улучшения безрецидивной и ОВ этой категории больных. Особого внимания заслуживает проведение предоперационной или неоадъювантной ХТ мышечно- инвазивного РМП.

Цель исследования

– улучшение результатов лечения мышечно-инвазивного РМП.

Материалы и методы

В рамках когортного исследования 125 больных инвазивным РМП был сделан кросекционный анализ. Из них мужчин 114, женщин - 11, Методом случай-контроль больные были разделены на 2 группы. Больным основной группы (n = 42) на первом этапе с лечебно-диагностической целью проводили ТУР мочевого пузыря: было выполнено удаление всей опухоли, видимой для глаза, или максимально возможного объема опухоли при обширном процессе. Материал отправляли на патоморфологическое исследование и в случае подтверждения инвазивного процесса проводили ИГХ-исследование. Показаниями к применению предоперационной ХТ служило наличие верифицированного инвазивного РМП с отсутствием клинических признаков иноперабельности процесса, а также гематологические и биохимические показатели, допускающие проведение системной ХТ. Гистологическая форма РМП в основном была представлена уротелиальной карциномой различной степени дифференцировки, преобладала умеренно дифференцированная форма. Пациентам проводили 2 курса неоадъювантной. ПХТ по схеме гемзар в дозе 1000 мг/м² в 1-й день и 8-й дни + цисплатин – 75мг/м² в 1-й день. Курс повторяли через 3 нед. Через 3 нед после проведения 2-го курса неоадъювантной терапии выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию с различными вариантами деривации мочи.

Больным контрольной группы, (n = 83) выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию с различными вариантами деривации мочи.

Қазіргі кезде операция алдында немесе неоадьювантті ХТ инвазиялық-бұшықетті емдеу үшін РМП. Науқастардың негізгі тобы (n = 42) бірінші сатыда диагностикалық-ем жүргізу мақсатымен несеп қуығына ТУР жүргізілді, артқы 2 курс неоадьювантпен қосқанда. ПХТ гемзар кестесі бойынша дозасы 1000 мг/м² 1-ші күні және 8-ші күндері + цисплатин -75 мг/м² 1-ші күні. 3 аптадан кейін 2-ші курс жүргізіліп, неоадьювантті терапия орындалды.

Жедел емдеу – радикальді цистэктомия әр түрлі варианттар мен зәр деривациялары. Бақылау тобындағы науқастар, (n = 83) жедел ем қолданды – радикальді цистэктомия. Негізгі топтағы тірі қалу нәтижесінің көрсеткіші – 78,6% бақылау тобы - 69,9%. Жақсы қорытынды НАПХТ алғандар. Науқастардан РМП алынды, мынадай оқиғаларда егер ісік оқшауланып бұшықет көлемінен асып кетсе (88,5% - негізгі, 75,9% - бақылау тобында).

Больным основной группы (n = 42) на первом этапе с лечебно-диагностической целью проводили ТУР мочевого пузыря с последующими 2 курсами неоадъювантной ПХТ по схеме гемзар в дозе 1000 мг/м² в 1-й день и 8-й дни + цисплатин – 75мг/м² в 1-й день. Через 3 нед после проведения 2-го курса неоадъювантной терапии выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию с различными вариантами деривации мочи. Больным контрольной группы, (n = 83) выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию. более высокие результаты общей выживаемости в основной группе - 78,6%, в контрольной- 69,9%. Лучшие результаты применения НАПХТ получены у больных РМП в случае если опухоль локализована в пределах мышечной оболочки (88,5% - в основной, 75,9% - в контрольной)

Now preoperative or neoadjuvant chemotherapy actually for treatment of muscle-invasive bladder cancer. Study group (n = 42) in the first stage of treatment was performed TUR of bladder; then conducted 2 courses of neoadjuvant. PCTs by scheme: Gemzar at a dose of 1000 mg/m² day 1 and 8 th days and cisplatin - 75mg/m² in the 1 st day. The course was repeated after 3 weeks. 3 weeks after the last course of neoadjuvant therapy are performed surgical treatment - radical cystectomy with various urinary diversion. Patients in the control group, (n = 83) performed surgical treatment - radical cystectomy with various urinary diversion. Better results in overall survival are show in the study group - 78,6%, in control group - 69.9%. Neoadjuvant chemotherapy demonstrated the decrease in the number of postoperative complications and mortality. Significantly NAPHT proven to be effective only in stage II, if the tumor is localized within the muscular layer (88,5% - in the study group, 75,9% - in control group). The data obtained justify further study of the efficacy of neoadjuvant chemotherapy

Функции дожития

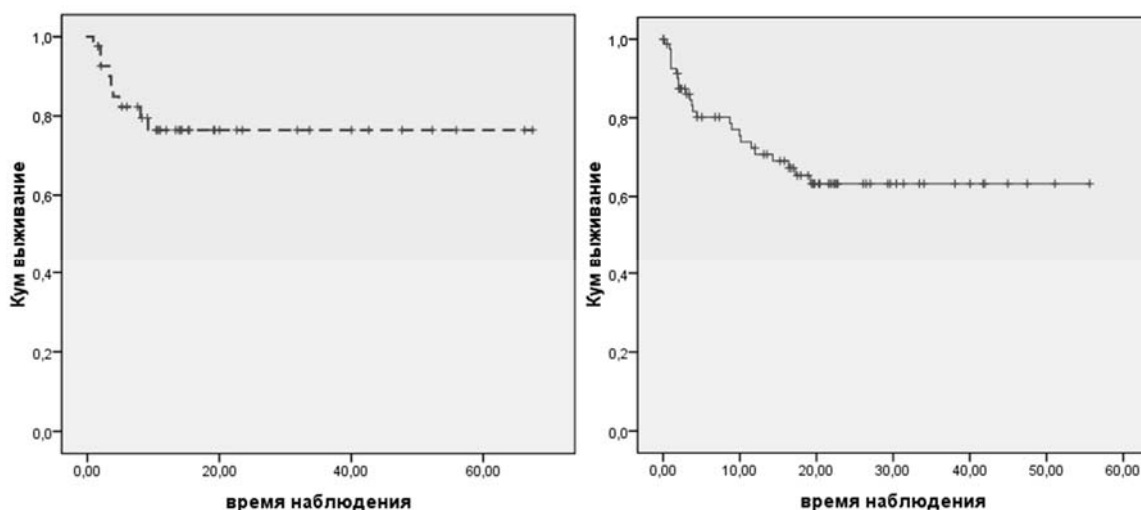
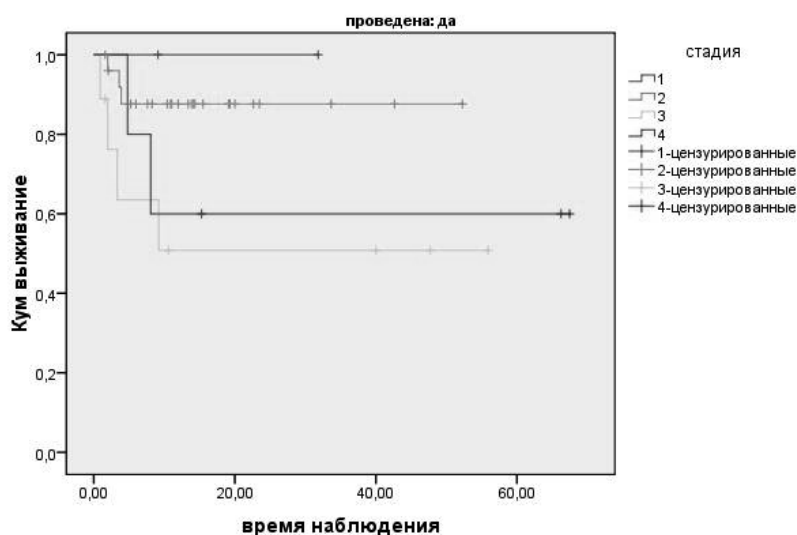


Рисунок 1, Рисунок 2. НАПХТ + радикальная цистэктомия (n = 42) радикальная цистэктомия (n = 83)

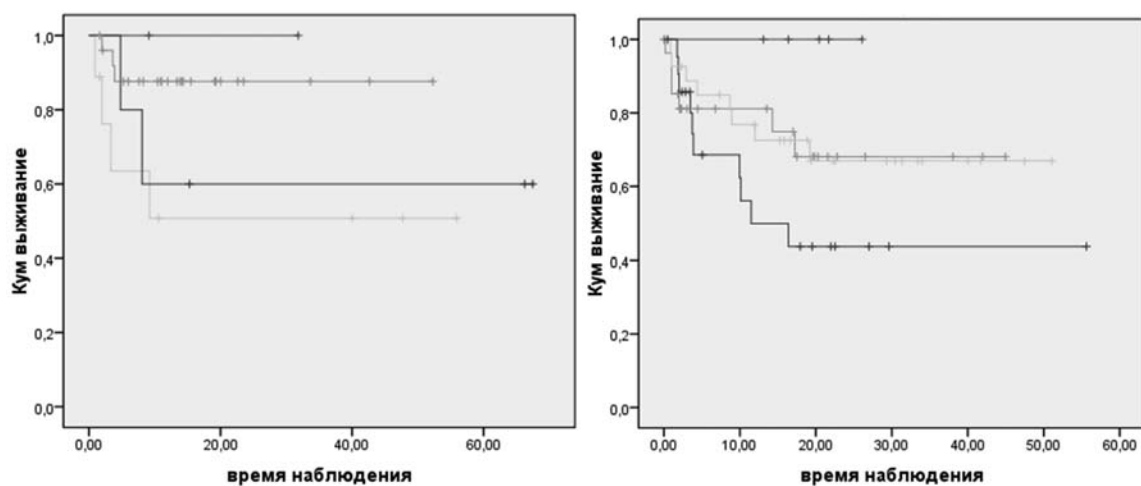


Рисунок 3, Рисунок 4. НАПХТ + радикальная цистэктомия (n = 42) радикальная цистэктомия (n = 83)

Результаты

Всем больным основной группы после осуществления 2 курсов неадъювантной системной ХТ проводили контрольное комплексное обследование. Выраженных осложнений при проведении лечения, требующих отмены ХТ, не выявлено. Послеоперационной летальности в данной группе больных не зарегистрировано. Пациентам

с T3 и T4, а также с наличием метастазов в регионарные ЛУ продолжено проведение системной ХТ в адъювантном режиме по той же схеме.

В зависимости от проведенной НАПХТ более высокие результаты общей выживаемости в основной группе - 78,6%, в контрольной - 69,9% представлена на (рис 1,2). При сравнении показателей выживаемости в зависимости от стадии опухолевого процесса (рис3,4) достоверно до-

казана эффективность НАПХТ только во II стадии (88,5% - в основной, 75,9% - в контрольной), показатели выживаемости при III и IV стадиях хуже чем в контрольной, что свидетельствует о неэффективности проведения НАПХТ у больных местно- распространенным раком (T3, T4, N+).

Выводы

Использование неoadъювантного подхода в лечении мышечно-инвазивного РМП является перспективным путем улучшения отдаленных результатов. На данный момент проведены исследования непосредственных результатов лечения. В ходе осуществления неoadъювантной ПХТ по данной схеме продемонстрировано отсутствие увеличения числа послеоперационных осложнений и летальности. Лучшие результаты применения НАПХТ получены у больных РМП в случае если опухоль локализована в пределах мышечной оболочки (стадия II). Полученные данные оправдывают дальнейшее изучение эффективности применения неoadъювантной ХТ.

	НАПХТ + радикальная цистэктомия (n = 42)	радикальная цистэктомия (n = 83)
Средний возраст	54,9 (42-70л)	58,7 (31-82г)
Среднее время наблюдения после радикальной цистэктомии	18,17 мес	15,48 мес
Стадия, (выживаемость, %)		
Стадия I	2 (100%)	5 (100%)
Стадия II	26 (88,5%)	29 (75,9%)
Стадия III	9 (55,6%)	27 (70,4%)
Стадия IV	5 (60%)	22 (54,5%)
Всего	42 (78,6%)	83 (72,8%)
N+	5 (11,9%)	16 (19,3%)
M+	2 (4,8%)	4 (4,8%)
Локорегионарный рецидив	1 (2,4%)	4 (4,8%)
Степень гистологической дифференцировки		
G1	4 (9,5%)	4 (4,8%)
G2	26 (61,9%)	48 (57,8%)
G3	10 (23,8%)	28 (33,7%)
плоскоклеточный рак и аденокарцинома	2 (4,8%)	3 (3,6%)
Варианты деривации мочи		
Операция по Хаутману	26 (61,9%)	31 (41%)
Операция по Стюдеру	7 (16,7%)	11 (13,7%)
Илеумконduit по Бриккеру	4 (9,5%)	23 (27,7%)
Уретерокутанеостомия	4 (9,5%)	12 (14,5%)
Гетеротопический мочево й пузырь	1 (2,4%)	3 (3,6%)
Осложнения		
Восходящий пиелонефрит	8 (19,0%)	6 (7,2%)
Мочевые свищи	4 (9,5%)	12 (14,5%)
Парез кишечника	2 (4,8%)	2 (2,4%)
Несостоятельность кишечных анастомозов	1 (2,4%)	1 (1,2%)
ТЭЛА	1 (2,4%)	1 (1,2%)
ОПН	-	3 (3,6%)
кровотечение	-	1 (1,2%)
Острая сосудистая недостаточность	-	2 (2,4%)
Несостоятельность резервуаро- мочеточникового анастомоза	-	2 (2,4%)
Острый орхит	-	1 (1,2%)